

PROTOCOLO DE HEMATURIA MACROSCÓPICA EN UOME

Unidad de Observación de Media Estancia

1. Objetivo

Manejo protocolizado de pacientes con hematuria macroscópica estable y diagnóstico urológico etiológico filiado, en estancia corta (< 36 h).

2. Criterios de admisión en la UOME

2.1 Etiología urológica filiado que no precisa ampliar estudios en el momento actual.

2.2 Estabilidad hemodinámica: TAS $\geq$ 100 mmHg, FC < 110 lpm.

2.3 Sat O₂ > 92%

2.4 Hb > 9-10 g/dL o estable respecto a valor previo.

2.5 Necesidad de lavado vesical continuo/intermitente sin criterios de ingreso

3. Criterios de exclusión

3.1 Inestabilidad hemodinámica

3.2 Anemización importante (> 2 g Hb) o necesidad transfusional

3.3 Retención recurrente

3.4 Deterioro renal obstructivo

3.5 Fiebre o sepsis

4. Objetivos en la UOME

4.1 Mantener permeabilidad vesical y aclaramiento de hematuria.

4.2 Evitar retención por coágulos.

4.3 Detectar anemia progresiva.

4.4 Evitar ingreso innecesario.

5. Estrategia diagnóstica y control evolutivo

5.1 El paciente será reevaluado tras valoración inicial en Urgencias.

5.2 Reevaluación médica:

- A las 4-6 h.
- Reevaluación global a las 12-24 h.

5.3 Control hemograma $\pm$ bioquímica a las 12-24 h si presenta:

- Hematuria moderada/importante.
- Lavado continuo mantenido.
- Anticoagulación.
- Hb límite (10 g/dL).
- Ancianos o frágiles.

5.4 Signos de alarma:

- Descenso Hb > 2 g/dL.
- Hb $< 8-9$ g/dL.
- Deterioro de función renal.
- Oliguria persistente.

6. Estrategia terapéutica

6.1 Sonda Foley 3 vías 20-22 Ch.

6.2 Sonda 24 Ch si coágulos abundantes.

6.3 Lavado manual inicial con SF para extracción de coágulos. Posteriormente, 2 bolsas iniciales a chorro con disminución de velocidad de irrigación posterior paulatina.

6.4 Irrigación continua con SF 0,9% hasta resolución de hematuria.

6.5 Ritmo orientativo adaptado a la situación del paciente:

- Hematuria moderada: 150-250 ml/h
- Hematuria intensa: 250-500 ml/h inicialmente

6.6 Reevaluar ingreso si: lavado continuo a alto flujo > 24 h y ausencia de tendencia al aclaramiento.

7. Controles de enfermería

7.1 Vigilancia de permeabilidad vesical.

7.2 Registro de coágulos.

7.3 Balance hídrico: Volumen de irrigación / débito urinario.

7.4 Vigilancia de dolor suprapúbico.

7.5 Detección precoz de obstrucción.

7.6 Registrar control de constantes:

- Cada 4 h durante las primeras 12 h.
- Posteriormente cada 6-8 h si hay estabilidad HD.

8. Anticoagulación

8.1 Revisar siempre: tipo de anticoagulante, indicación, última dosis, función renal.

8.2 Valorar suspensión temporal de NAC/DOAC durante hematuria activa.

8.3 Reintroducción habitual a las 24-48 h tras control del sangrado.

8.4 No se recomienda puente sistemático con HBPM salvo muy alto riesgo trombótico.

9. Antibióticos

9.1 No se recomienda antibioterapia profiláctica rutinaria asociada a sondaje vesical o lavado continuo.

9.2 Valorar tratamiento antibiótico individualizado si:

- Fiebre
- Sospecha de ITU
- Piuria significativa
- Inmunosupresión
- Manipulación urológica compleja

10. Criterios de alta

10.1 Estabilidad hemodinámica.

10.2 Ausencia de retención.

10.3 Hematuria leve tolerable y Hb estable.

10.4 Dolor controlado.

10.5 Seguimiento urológico garantizado.

10.6 Puede realizarse alta con sonda vesical permeable.

10.7 En pacientes no portadores habituales: mantener sonda transitoria varios días (habitualmente 5-7 días) según evolución y criterio urológico.

11. Criterios de ingreso hospitalario

11.1 Lavado continuo > 24-36 h sin aclarado de hematuria.

11.2 Hematuria no controlable, descenso progresivo de Hb o necesidad transfusional.

11.3 Retención recurrente.

11.4 Deterioro renal.

11.5 Dolor refractario.

11.6 Necesidad de procedimiento urológico.

12. Recomendaciones al alta

12.1 Nueva consulta inmediata si:

- Obstrucción de sonda o ausencia de diuresis.
- Aumento brusco de hematuria o coágulos abundantes.
- Fiebre.
- Síncope o mareo.

12.2 Mantener hidratación adecuada.

12.3 Evitar esfuerzos físicos.

12.4 Seguimiento por Urología.

13. Bibliografía

1. EAU Guidelines on Urological Infections and Urological Emergencies. European Association of Urology (EAU).
2. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer. European Association of Urology.
3. American Urological Association (AUA). Hematuria Guidelines.
4. NICE Guideline: Suspected cancer - recognition and referral (haematuria).
5. Steffel J et al. EHRA Practical Guide on the use of NOACs in patients with atrial fibrillation. Europace. 2021.
6. Recomendaciones SEC-SETH sobre manejo perihemorrágico y perioperatorio de anticoagulación oral.
7. Protocolos Urológicos HUCA / Hospital San Agustín de Avilés / Hospital de Cabueñes.
8. Campbell-Walsh-Wein Urology. Manejo de hematuria macroscópica y retención por coágulos.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON:

HEMATURIA/ ITU

En un paciente con hematuria o ITU, se debe vigilar tanto la cantidad y características del sangrado como los signos de posibles complicaciones urinarias o hemodinámicas.

Signos y síntomas a vigilar y registrar

- **Estado general:**
 - ♣ Fatiga
 - ♣ Ansiedad
 - ♣ Alteración del nivel de conciencia en casos graves.
- **Control de diuresis:**
 - ♣ Cantidad de orina
 - ♣ Oliguria o anuria
 - ♣ Retención urinaria, especialmente si hay coágulos.
 - ♣ Balance hídrico del lavado si tuviera
- **Dolor:**
 - ♣ Dolor lumbar en flancos (posible afectación renal)

SERVICIO DE URGENCIAS

- ♣ Dolor suprapúbico
- ♣ Disuria o escozor al orinar
- ♣ Cólico renal
- ♣ Urgencia urinaria
- ♣ Control del dolor. Necesidad de analgesia de rescate
- **Signos de obstrucción urinaria**
 - ♣ Dificultad para orinar
 - ♣ Globo vesical
 - ♣ Chorro urinario interrumpido por coágulos
- **Signos de infección**
 - ♣ Fiebre
 - ♣ Escalofríos
 - ♣ Mal olor en la orina
 - ♣ Orina turbia
 - ♣ Piuria
- **Signos hemodinámicos:**
 - ♣ Taquicardia
 - ♣ Hipotensión
 - ♣ Palidez
 - ♣ Mareo o debilidad, especialmente si el sangrado es abundante.

Registros Específicos en la Historia Clínica

- **Valoración de la hematuria**
 - ♣ Agua de lavar carne
 - ♣ Presencia de coágulos
 - ♣ Aclaramiento durante el lavado/persistencia
- **Revisión de permeabilidad y normoposición de la sonda vesical si precisa.**

Signos de alarma

- Hipotensión, taquicardia (posible sepsis)

- Alteración del estado mental (confusión, desorientación)
- Náuseas/vómitos intensos
- Dolor intenso no controlado

BIBLIOGRAFÍA:

1. - Ferrer Tarrés JM, Prat Marín A, Tomás Vecina S. Revisión de la utilización de las áreas de observación de urgencias hospitalarias. Med Clin (Barc). 2007;128(6):224-31. Quirónsalud.
2. - Inhaladores de cartucho presurizado: técnica de inhalación. Escuela de Pacientes Neumología. Madrid: Quirónsalud; 2023. Disponible en: <https://www.quironsalud.com> [Acceso 04 sept 2026]. Servicio Andaluz de Salud.
3. - Guía de diseño y organización de servicios de urgencias hospitalarias. Sevilla: Consejería de Salud; 2016. Soler Gómez Y, Fernández Viñado DM, Martínez Fernández C, et al.
4. - Atención de enfermería al paciente politraumatizado por accidente de tráfico: enfoque integral en la emergencia. Rev Sanitaria Invest. 2025;6(7):e2660-7085. Sánchez Reyes E, Pinal Moreno E, Ortega Vargas MC.
5. - Guía clínica de enfermería del enfermo con insuficiencia cardíaca. Rev Enferm IMSS. 2004;12(3):155-62. Grupo de Trabajo de EPOC SEMERGEN.
6. - Protocolo de manejo del paciente con EPOC agudizado en urgencias. SEMERGEN. 2020;46(Supl 1):1-12. Gómez Martínez A, González Vallejo ML, García Cuesta P.
7. - Plan de cuidados enfermeros en el paciente con EPOC y neumonía según taxonomía NANDA-NIC-NOC. Rev Enferm CyL. 2018;10(2):45-58. Gobierno de Canarias.
8. - Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos: Traumatismos II. Las Palmas: Consejería de Educación; 2021. Universidad de Salamanca.
9. - Guía docente Enfermería en Urgencia y Riesgo Vital. Grado en Enfermería. Ávila: USAL; 2024-2025. Mayo Clinic.

SERVICIO DE URGENCIAS

10. - Inhaladores para el asma: ¿cuál es el indicado para usted? Rochester: Mayo Foundation; 2024. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org> [Acceso 04 sept 2026].
11. - Guía de actuación en urgencias de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)
12. - Cuidados de enfermería en el paciente crítico en urgencias de García González, M., et al. (2020)
13. - Manejo del paciente con dolor torácico en urgencias de López López, J., et al. (2019)
14. - Emergencias (revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)
15. - Enfermería de Urgencias (revista especializada en cuidados de enfermería en urgencias)
16. - SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) - Guías y protocolos
17. - SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias) - Recursos y documentos